

약제 요양 급여의 적정성 평가 결과

pazufloxacin mesilate 390.6mg, 651.0mg
(파주크로스주 300mg, 500mg, 한올바이오파마)

☐ **제형, 성분·함량 :**

- 파주크로스주 300mg: pazufloxacin mesilate 390.6mg(as pazufloxacin 300mg)
- 파주크로스주 500mg: pazufloxacin mesilate 651.0mg(as pazufloxacin 500mg)

☐ **효능 효과 :**

<유효균종>

이 약 파주플록사신에 감수성이 있는 포도상구균, 연쇄상구균속(폐렴구균을 제외), 장구균, 모락셀라(브란하멜라), 카타라리스, 대장균, 시트로박터속, 크렙시엘라속, 엔테로박터속, 세라치아속, 프로테우스속, 모가넬라 모르가니, 프로비덴시아속, 인플루엔자속, 녹농균, 아시네토박터속, 레지오넬라속, 박테로이데스속, 프레보텔라속

<적응증>

- 복합성 요로감염(신우신염, 방광염 포함), 세균성 폐렴, 만성기관지염의 급성악화

☐ **약제급여평가위원회 심의 일**

2010년 제7차 약제급여평가위원회 : 2010년 7월 22일

2010년 제11차 약제급여평가위원회 : 2010년 10월 21일[재평가]

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 1차 평가 결과(2010년 제7차 약제급여평가위원회)

○ 비급여

- 신청품은 “복합성 요로감염(신우신염, 방광염 포함), 세균성 폐렴, 만성기관지염의 급성 악화”에 허가받은 약제로, 대체약제와의 상대적 임상적 유용성이 불분명하므로 비급여함.

□ 재평가 결과(2010년 제11차 약제급여평가위원회)

○ 비급여(기심의결과 유지)

- 신청품은 “복합성 요로감염(신우신염, 방광염 포함), 세균성 폐렴, 만성기관지염의 급성 악화”에 허가받은 약제로, 대체약제와의 상대적 임상적 유용성이 불분명하므로 비급여함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “복합성 요로감염(신우신염, 방광염 포함), 세균성 폐렴, 만성기관지염의 급성 악화”에 허가¹⁾받은 약제로, 대상 질환은 희귀질환에 해당하지 않으며, 현재 해당 적응증에 허가받은 ciprofloxacin, levofloxacin 등이 등재되어 있으므로, 대체가능성을 고려시 진료 상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 ciprofloxacin과 유사한 특성을 갖는 fluoroquinolone계 항균제임²⁾.
 - pazufloxacin은 호기성, 통성혐기성 및 혐기성 그람양성균 및 그람음성균에 대해, ciprofloxacin과 동일한 정도의 항균스펙트럼을 보이며³⁾ ciprofloxacin의 대체약제로 언급됨⁴⁾
- 신청품은 동일 계열 fluoroquinolone계 항생제 주사제와의 직접·간접비교임상시험자료가 검색되지 않음.
 - 제약사는 ■■■■ 제출하였으나 간접 비교 논문의 대상환자군 간 차이가 있고 결과변수의 정의가 다른 등 이질성이 있으므로 간접 비교 분석 결과에 불확실성이 존재함.
- 신청품은 세균성 폐렴, 만성 기도 감염증, 복합성 요로감염환자에 대해 ceftazidime과 비교시 임상적 유효성이 비열등하고, 만성기관지염의 급성악화, 세균성 폐렴에서 세균

학적 박멸률은 ceftazidime 대비 열등함.

- 만성 기도 감염증환자(n=203)를 대상으로 ceftazidime을 대조약으로 14일간 정맥투여하여 3상 무작위비교임상시험(맹검)을 수행한 결과, 임상적 유효성⁵⁾은 신청품이 93.2%, ceftazidime군은 91.5%이었고 비열등성(임상적 동등성)이 입증됨. 원인균이 추정된 84예에 대하여 세균학적 박멸률은 신청품이 열등하였음(신청품군 65%, ceftazidime군 90.2%, $p=0.014$)⁶⁾.
- 세균성 폐렴, 폐농양 환자(n=232)에서 ceftazidime을 대조약으로 2주간 정맥투여하여 3상 무작위비교임상시험(맹검)을 수행한 결과, 임상적 유효성은 신청품이 90.7%, ceftazidime군은 89.9%로 비열등성(임상적 동등성)이 입증됨. 원인균이 추정된 85예에 대하여 세균학적 박멸률은 신청품이 열등하였음(신청품군 81.1%, ceftazidime군 100%, $p=0.002$)⁷⁾.
- 복합성 요로감염환자(n=300)에서 ceftazidime을 대조약으로 5일간 정맥투여하여 3상 무작위비교임상시험(맹검)을 수행한 결과, 임상적 유효성은 신청품이 92.5%, ceftazidime군은 87.4%로 비열등성이 입증됨. 세균학적 반응(박멸률)은 두 군간 차이가 통계적으로 유의하지 않음⁸⁾.

○ 비용 효과성

- 신청품은 fluoroquinolone계 항생제로 “복합성 요로감염(신우신염, 방광염 포함), 세균성 폐렴, 만성기관지염의 급성악화”에 fluoroquinolone계 항생제들이 추천되므로⁹⁾¹⁰⁾¹¹⁾¹²⁾ levofloxacin, ciprofloxacin HCl, moxifloxacin HCl, ofloxacin, pefloxacin methanesulfonate 등 동일 기전의 주사제들을 신청품의 대체약제로 선정함
- 신청품의 일일투약비용(■)은 대체약제의 가중일일투약비용(■)에 비해 저렴함.

○ 재정 영향¹³⁾

- 제약사 제출 예상사용량¹⁴⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액¹⁵⁾은 1차년도에 약 ■, 3차년도에 약 ■이 되고, levofloxacin, ciprofloxacin HCl, moxifloxacin HCl, ofloxacin, pefloxacin methanesulfonate 주사제의 대체로 재정소요금액은 1차년도에 약 ■, 3차년도에 약 ■이 절감될 것으로 예상됨¹⁶⁾¹⁷⁾

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 일본에 등재되어있음.

Reference

- 1) ■■■
 - 2) Martindale 36th ed.(2009). Pharmaceutical Press
 - 3) 일본의약품집(Drugs in Japan 2010), Jiho.
 - 4) '호흡기 전염병에 관한 가이드라인' 중 '성인 원내 폐렴 진료 가이드라인', 일본 호흡기 학회(2008)
 - 5) ■■■
 - 6) Shimada et al. Japanese Journal of Chemotherapy VOL.48;NO.6;464-494(2000)
 - 7) Shimada et al. Japanese Journal of Chemotherapy Vol. 48;No.6;433-463(2000)
 - 8) Kumazawa Joichi et al. Nishinohon Journal Of Urology Vol.62;No.8;472-500(2000)
 - 9) 지역사회획득 폐렴의 치료지침 권고안, 감염과 화학요법, vol.41; no.3(2009)
 - 10) Harrison's Principles of Internal Medicine, 17th edition(2008), McGraw-Hill
 - 11) 감염학(2007), 군자출판사
 - 12) 대한결핵및호흡기학회(■■■)
 - 13) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
 - 14) ■■■
 - 15) 파주크로스주 300mg, 500mg 각각의 예상사용량에 의한 절대재정소요금액(예상 총약제비)의 합임
 - 16) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
 - 17) 재정증감분=(신청품의 일일투약비용-대체약제 가중 일일 투약 비용)×(신청품 예상총투약일)^{a)}
 - a) ■■■
- ■■■